Consideraciones clínicas y diagnósticas del dolor neuropático

Dolor crónico: dolor neuropático

tech

CONTENIDO

1. Introducción
2. Presentación clínica del dolor neuropático
3. Sintomatología del dolor neuropático
4. Anamnesis en el diagnóstico de dolor neuropático
5. Exploración física en el dolor neuropático
6. Evaluación del dolor neuropático
7. Técnicas diagnósticas para el dolor neuropático
8. Bibliografía

Introducción

En ausencia de biomarcadores, el diagnóstico de dolor neuropático está basado fundamentalmente en criterios clínicos. El reto es diferenciar el dolor neuropático de otros tipos de dolor y diagnosticar la lesión o enfermedad que lo origina.

A pesar de la prevalencia del dolor neuropático en la práctica clínica, su complejidad (síntomas y signos, espontáneos y evocados, acompañados de posibles trastornos somatosensoriales, positivos o negativos) y las circunstancias que lo rodean, hacen que su diagnóstico a menudo sea tardío y en ocasiones erróneo, dando lugar al consecuente retraso en el tratamiento.

Presentación clínica del dolor neuropático

Escuchar a los pacientes es el primer paso para la identificación del dolor neuropático. Se ha demostrado en los últimos años que las palabras utilizadas para describir el dolor difieren entre los pacientes con dolor neuropático y no neuropático y que, a pesar de muchas causas, el dolor neuropático; se caracteriza por un número relativamente pequeño de cualidades y características (quemazón, descarga, disestesia y alodinia) que lo distinguen de otro tipo de dolor. Esta observación ha llevado al desarrollo y validación de una serie de herramientas clínicas en forma de cuestionarios sencillos, basados en los síntomas para la detección y la identificación del dolor neuropático en la práctica clínica. Sin embargo, una cuidadosa evaluación clínica sigue siendo necesaria, ya que estas herramientas de detección, no logran identificar entre el 10 % y el 20 % de los pacientes con dolor neuropático.

Sintomatología del dolor neuropático

Al realizar la historia clínica al paciente, es importante recordar que el dolor es una experiencia subjetiva y puede ser descrito de manera diferente por diferentes personas. En general, el profesional debe establecer la intensidad, calidad, duración y localización de los síntomas, y si el dolor es espontáneo o provocado; es decir, si la presencia de un estímulo provoca la sintomatología o es independiente, ya que esto puede afectar a la elección del tratamiento. Típicamente, el dolor neuropático tiene síntomas sensoriales positivos y negativos *(tabla 1)*. La terminología usada frecuentemente para la descripción del dolor neuropático se define en la *tabla 2*.

Anamnesis en el diagnóstico de dolor neuropático

En los casos de dolor neuropático crónico es importante incluir en su evaluación la comorbilidad psicológica, trastornos del sueño, problemas relacionados con su actividad laboral, el soporte sociofamiliar y las expectativas de tratamiento que tiene el paciente al respecto. El componente ansioso-depresivo puede causar reacciones exageradas al dolor. Es muy importante comunicarse claramente con los pacientes y establecer objetivos realistas del tratamiento.

Exploración física en el dolor neuropático

La exploración sensitiva es la parte fundamental del examen físico. Los hallazgos en el área dolorosa se comparan con el área contralateral en el dolor unilateral, y en otras zonas, el eje proximal-distal en el dolor bilateral. La relación entre un estímulo y la sensación percibida puede cambiarse cuantitativa, cualitativa, espacial y temporalmente.

La identificación de una enfermedad neurológica o una lesión nerviosa se basa en una búsqueda sistemática de anomalías neurológicas en el examen clínico. Una exploración neurológica detallada ha de realizarse en el paciente con dolor neuropático (por ej.: exploración motora, pares craneales, reflejos tendinos, etc.).

La evaluación de la función del sistema nervioso autónomo (por ej.: cambios de temperatura y de coloración de la piel, trastornos vasomotores y tróficos, etc.) es importante, especialmente ante la sospecha de neuropatía por fibras pequeñas o síndrome de dolor regional complejo. Basándose en el examen físico existe la posibilidad de establecer una hipótesis de localización de la lesión responsable *(figura 1)*.

Síntomas positivos	Síntomas negativos.
Hormigueo	Adormecimiento
Picazón	Entumecimiento
Descarga, lancinante.	
Calor-Urente	
Lacerante	
Tirante-apretado	
Pinchazos-agujetas	

Tabla 1. Síntomas positivos y negativos de dolor neuropáticos

Terminología dolor neuropático
Parestesia: Sensación anormal ya sea espontánea o evocada
Disestesia: Sensación anormal y desagradable que se genera de forma espontánea o es provocada por un estímulo
Hipoestesia: Disminución de la sensibilidad a la estimulación, excluyendo los sentidos especiales
Hiperestesia: Aumento de la sensibilidad a la estimulación
Hipoalgesia: Disminución de la respuesta dolorosa ante un estímulo habitualmente doloroso
Hiperalgesia: Respuesta dolorosa aumentada ante un estímulo que normalmente es doloroso. Asociado habitualmente a las situaciones de hipersensibilización central o periférica.
Alodinia: Dolor secundario a un estímulo que normalmente no desencadena dolor. La definición implica un cambio cualitativo en la sensación para diferenciarlo de una hiperestesia.

Tabla 2. Terminología asociada a dolor neuropático.

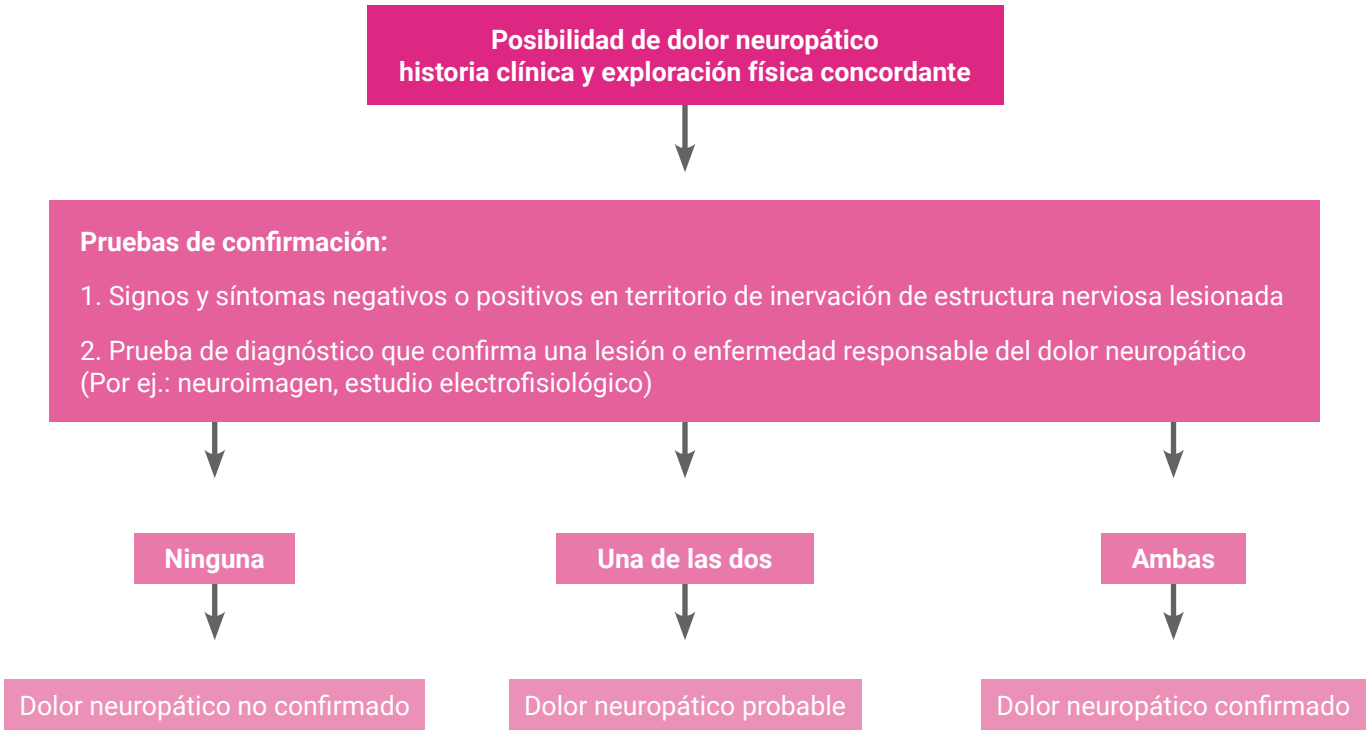

Figura 1. Algoritmo de diagnóstico del dolor neuropático

Evaluación del dolor neuropático

Durante los últimos 20 años se han ido desarrollando herramientas clínicas en forma de cuestionarios haciendo uso de los descriptores verbales de dolor neuropático más comúnmente utilizados. Tienen un diseño simple y fácil con el fin de ayudar al profesional a la identificación de este tipo de dolor, especialmente en condiciones complejas.

Existen múltiples cuestionarios validados que pueden ser utilizados para la identificación del dolor neuropático: The LANSS Pain Scale, *The Neuropathic Pain Questionnaire* (NPQ), *Douleur neuropathique en 4 questions* (DN4), *PainDetect, ID Pain.* Tres de ellos (LANSS, DN4 y Pain Detect) son ampliamente utilizados y están validados al castellano con gran éxito y rápida difusión. Estas herramientas mostraron una excelente sensibilidad (desde 74 % a 85 %) y especificidad (desde 76 % a 90 %) para discriminar entre dolor neuropático y no neuropático, confirmándose después en diversos estudios en múltiples idiomas. Su principal aplicación es la detección del dolor neuropático en al ámbito sanitario: médicos, enfermeros, fisioterapeutas, odontólogos, aunque también se han utilizado ampliamente en la población general. Al igual que cualquier herramienta clínica, estos cuestionarios tienen sus limitaciones por lo que sigue siendo fundamental una historia clínica exhaustiva y el examen físico correspondiente. En resumen, se consideran de utilidad las escalas y cuestionarios, todas ellas válidas y ninguna concluyente, siendo el investigador quien debe decidir cuál utilizar en cada caso en función de su experiencia y del objetivo buscado. La evaluación psicológica y los test de calidad de vida específicos, pueden ser muy aconsejables en determinados cuadros de dolor neuropático crónico *(figuras 2 y 3)*.

A. CUESTIONARIO SOBRE EL DOLOR

—Piense en *cómo ha sido su dolor en la última semana.*
—Por favor, indique si algunas de las siguientes descripciones se corresponden exactamente con el dolor que usted siente.

1. ¿Percibe el dolor como sensaciones extrañas y desagradables en su piel? Esas sensaciones podrían describirse con palabras como picazón, hormigueo, pinchazos y agujetas.

a) NO – El dolor que siento no se parece realmente a eso (0)
b) SÍ – Tengo esas sensaciones con frecuencia (5)

2. ¿Su dolor hace que la piel de la zona dolorida tenga un aspecto diferente al normal? Ese aspecto podría describirse con palabras como moteado o más rojo o rosa de lo normal.

a) NO – El dolor que siento no afecta realmente a mi piel (0)
b) SÍ – He observado que el dolor hace que mi piel tenga un aspecto diferente al normal (5)

3. ¿Hace su dolor que la piel afectada tenga una sensibilidad anormal al tacto? Esa sensibilidad anormal puede describirse como sensación desagradable ante ligeros toques de la piel, o dolor al usar ropa apretada.

a) NO – El dolor que siento no provoca una sensibilidad anormal de la piel en esa zona. (0)
b) SÍ – Mi piel parece tener una sensibilidad anormal al tacto en esa zona. (3)

4. ¿Aparece su dolor repentinamente y a ráfagas, sin razón aparente cuando está usted quieto? Esas sensaciones pueden describirse con palabras como descargas eléctricas, sobresalto y ráfaga.

a) NO – El dolor que siento no es realmente así. (0)
b) SÍ – Tengo esas sensaciones bastante a menudo. (2)

5. ¿Su dolor le hace sentir como si la temperatura de la piel en la zona dolorida hubiera cambiado de forma anormal? Esas sensaciones pueden describirse con palabras como calor y ardiente.

a) NO – En realidad no tengo esas sensaciones. (0)
b) SÍ – Tengo esas sensaciones bastante a menudo. (1)

Figura 2. Escala LANSS. (Continúa en la siguiente página)

B. EXPLORACIÓN SENSORIAL

La sensibilidad de la piel puede examinarse comparando la zona dolorida con una zona contralateral o adyacente no dolorida para determinar la presencia de alodinia y una alteración del umbral de pinchazo (UP).

1. ALODINIA

Se examina la respuesta a ligeros toques con un paño de algodón sobre la zona no dolorida y luego sobre la zona dolorida. En el caso de que se experimenten sensaciones normales en la zona no dolorida, pero sensaciones dolorosas o desagradables (hormigueo, náuseas) en la zona dolorida con los toques, existirá alodinia.

a) NO, sensación normal en las dos zonas. (0)
b) SÍ, alodinia sólo en la zona dolorida. (5)

2. UMBRAL DE PINCHAZO ALTERADO

Se determina el umbral de pinchazo comparando la respuesta a una aguja de calibre 23 (azul) acoplada al cilindro de una jeringa de 2 ml y colocada suavemente sobre la piel en una zona no dolorida y luego en una zona dolorida.

En el caso de que se sienta un pinchazo agudo en la zona no dolorida, pero una sensación diferente en la zona dolorida; p. ej., nada/sólo romo (UP elevado) o una sensación muy dolorosa (UP bajo), existirá una alteración del UP.

Si no se siente un pinchazo en ninguna de las dos zonas, se aumentará el peso de la jeringa y se repetirá el procedimiento.

a) NO, la misma sensación en las dos zonas. (0)
b) SÍ, un UP alterado en la zona dolorida. (3)

PUNTUACIÓN:

Se suman los valores entre paréntesis de la descripción sensorial y la exploración sensorial para obtener la puntuación total.

PUNTUACIÓN TOTAL (MÁXIMO 24) .....

Si la puntuación <12, es *poco probable* que mecanismos neuropáticos contribuyan al dolor del paciente.
Si la puntuación es ≥12, es *probable* que mecanismos neuropáticos contribuyan al dolor del paciente.

Figura 2. Escala LANSS.

Pregunta 1: ¿Tiene el dolor una o más de las siguientes características?		
	Sí	NO
1. Quemazón		
2. Frío doloroso		
3. Calambres eléctricos		
Pregunta 2: ¿Está asociado el dolor con uno o más de los siguientes síntomas en la misma zona?		
	Sí	NO
4. Hormigueo		
5. Alfileres y agujas		
6. Entumeciemiento		
7. Picazón		
EXÁMEN FÍSICO		
Pregunta 3: ¿Está el dolor localizado en una zona donde el exámen físico puede mostrar una o mas de las siguientes características?		
	Sí	NO
8. Hipoestesia al tacto		
9. Hipoestesia a pinchazos		
Pregunta 4: En la zona dolorosa, el dolor es causado o incrementado por:		
	Sí	NO
10. Cepillado suave de la piel		
Por cada respuesta positiva asigne un punto; por cada respuesta negativa asigne un valor de 0 (cero). Sume los puntos; si es mayor o igual a 4, se considera que hay dolor neuropático.		
Puntuación del paciente: /10		

Figura 3. Escala DN4.

Técnicas diagnósticas para el dolor neuropático

Varias pruebas complementarias (estudio electrofisiológico, pruebas sensoriales cuantitativas, pruebas de neuroimagen, biopsias, determinaciones analíticas, etc.) pueden utilizarse para identificar la lesión neurológica, potencialmente subyacente, que origina el dolor. Sin embargo, estas pruebas no miden el grado de dolor y no pueden confirmar la relación causal; por tanto, el diagnóstico depende de la interpretación que se realice por parte del profesional en un contexto clínico específico.

En conclusión, es fundamental la detección precoz y rápida del dolor neuropático, apoyándose en las pruebas correspondientes. La historia clínica es la mejor prueba diagnóstica, por tanto, el diagnóstico entre los profesionales puede resultar fácil una vez que puedan tomarse como referencia los diferentes parámetros diagnósticos del dolor neuropático: síntomas espontáneos (dolor urente, parestesias o dolor lancinante) y signos evocados (alodinia o hiperalgesia).

La utilización de escalas específicas de dolor neuropático, validadas en castellano, destacan como uno de los mejores sistemas de registro para la evaluación del dolor. Se basan en descriptores clínicos y simples exámenes, por lo que son un método orientativo para el diagnóstico de dolor neuropático, que pueden complementarse con una anamnesis correcta y una exploración neurológica de la zona lesionada.

La evaluación psicológica y los test de calidad de vida específicos, pueden ser muy aconsejables en determinados cuadros de dolor neuropático crónico.

El resto de las técnicas y pruebas diagnósticas son accesorias a la hora de diagnosticar un dolor neuropático, y en ningún caso, sustitutivas de la clínica.

No hay ninguna prueba diagnóstica que pueda determinar con exactitud el diagnóstico de dolor neuropático, sobre todo, cuando las lesiones se generan en nervios periféricos de pequeño tamaño.

Bibliografía

1. Bouhassira D, Attal N. Diagnosis and assessment of neuropathic pain: the saga of clinical tools. Pain. 2011; 152(3): 74-83.
2. Attal N, Bouhassira D, Baron R. Diagnosis and assessment of neuropathic pain through questionnaires. Lancet Neurol. 2018; 17 (5):456-66.
3. Cruccu G, Sommer C, Anand P, et al. EFNS guidelines on neuropathic pain assessment: revised 2009. Eur J Neurol. 2010;17(8): 1010-1018.
4. Bennett MI, The LANSS. Pain Scale: the Leeds assesment of neuropathic symptoms and signs. Pain. 2001; 92: 147-57.
5. Krause SJ, Backonja M. Development of a neuropathic pain questionnaire. Clin J Pain. 2003; 19:306-14.
6. Bouhassira D, Attal N, Achaar H, Boureau F, Brochet B, Bruxelle J, et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain. 2005;114: 29-36.
7. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tolle TR. painDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patient with back pain. Curr Med Res Opin. 2006; 22:1911-20.
8. Portenoy R. Development and testing of a neuropathic pain screening cuestionnaire: ID Pain. Curr Med Res Opin. 2006;22: 1555-65.
9. Pérez C, Gálvez R, Huelbes S, Insausti J, Bouhassira D, Díaz S, et al. Validity and reliability of the Spajish version of the DN4 (Douleur Neuropathique 4 questions) questionnaire for differential diagnosis of pain syndromes associated to a neuropathic or comatic component. Health Qual Life Outcomes. 2007;5: 66.
10. Gálvez R, Pardo A, Cerón J M, Villasante F, Aranguren JL, Saldaña M, Navarro A, Ruiz MA, Díaz S y Rejas J. Adaptación al castellano y validación psicométrica del cuestionario ID-Pain© para la detección de dolor neuropático. Med Clin. 2008;131(15):8-572.
11. De Andres J, Pérez Cajaraville J, Lopez-Alarcón MD, López-Millán JM, Margarit C, Rodrigo-Royo MD, Franco-Gay ML, Abejón D, Ruiz MA, López-Gomez V, Pérez M. Cultural adaptation and validation of the painDETECT scale into Spanish Clin J Pain. 2012;28(3):243-53.
12. M. T. Herrero V, Delgado S, Bandrés M, Ramírez M y Capdevila L. Valoración del dolor. Revisión comparativa de escalas y cuestionarios. Rev Soc Esp Dolor. 2018; 25(4): 228-236.